

Les urgences en oncologie: urgences métaboliques



Dr. Meguellati H

Pr. BENSALÉM. A

Service d'oncologie médicale

EH Didouche Mourad



Objectifs pédagogiques

- Savoir diagnostiquer une urgence oncologique
 - Savoir lever l'urgence
 - Connaitre la prévention des urgences
- 



Plan du cours:

- I. introduction

- II. Urgences métaboliques:

 - 1/ l'hypercalcémie

 - 2/ syndrome de lyse tumorale

 - 3/ Sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH)

 - 4/ insuffisance surrénalienne



I. introduction:

- tout événement aigu menaçant la vie du malade
- Les situations de détresse vitale en cancérologie peuvent être secondaires:
 - La pathologie primitive ou ses métastases.**
 - Le traitement.**
 - Les comorbidités qui peuvent se décompenser.**

I. Urgences métaboliques:

1/ l'hypercalcémie:

- $\text{Ca} \geq 105 \text{ mg/l}$ (N 90-105 mg/l). Une $\uparrow\uparrow$ plus de 120 mg/l comporte un risque potentiel (ca sup 2,62 mmol/L)
- $\text{Ca corrigée} = \text{Ca mesurée} - 0,025(40 - \text{Albumine})$

Etiologies:

- **Augmentation de la résorption osseuse** suite à une:
 - Hyperparathyroïdie
 - Sécrétion paranéoplasique de PTHrp
 - Des lésions osseuses lytiques
- **Ou un excès en vitamine D:** surdosage
- **Augmentation de la réabsorption rénale/ l'absorption** intestinale de calcium

I. Urgences métaboliques:

Manifestations cliniques:

Rénale	Polyuro polydipsie avec insuffisance rénale fonctionnelle Déshydratation
Gastro-intestinale	Anorexie, nausées, vomissements, constipation
neurologique	Léthargie, fatigue, irritabilité, trouble du sommeil, hypotonie, convulsion, coma
Cardiaque	Diminution de l' intervalle QT, trouble du rythme

II. Urgences métaboliques:

CAT:

- Basée sur l'association: réhydratation + biphosphonates
- Il dépend de la sévérité et de l'étiologie

1- hypercalcémie modérée: **ca inf 3,8 mmol/L et absence de signes de gravité:**

- Trt en salle médicale
- Réhydratation: 1 à 2 litres de sérum salé sur 1 à 4 heures puis 3 à 4 litres/ 24h
- Biphosphonates: zolédronate ou zométa: 4 mg dans 250 cc de NaCl 0,9% en 15mn à renouveler à 3 à 4 semaines
- Eviter le furosémide: risque d'aggravation de la déshydratation

2- hypercalcémie grave ou maligne: **ca sup 3,8 mmol/L et/ ou signes de gravité:**

- Transfert en réanimation
- Épuration extra-rénale, hydratation selon les mêmes modalités
- Calcitonine en association aux biphosphonates: 0,5 à 4 mg/ jour
- Corticoïdes: 1 à 3 mg/ jours en 3 fois

II. Urgences métaboliques:

2/ Syndrome de lyse tumorale:

A- Définition :

Secondaire à la **destruction massive tumorale**, spontanée ou provoquée, conduisant au relargage dans la circulation des composés intracellulaires. Le risque majeur étant l'**insuffisance rénale aiguë** soit par précipitation de cristaux phosphocalciques, soit par néphropathie uratique

B-Définit biologiquement par :

- hyperkaliémie ; hyperphosphatémie ; hypocalcémie ; hyperuricémie ; augmentation des LDH.

Risque principal est la constitution d'une insuffisance rénale oligo-anurique.

► **Facteurs favorisants :**

- l'importance de la masse tumorale ;
- le taux de renouvellement tumoral ;
- la sensibilité tumorale aux traitements cytotoxiques.
- Dysfonction rénale, déshydratation initiale

II. Urgences métaboliques:

B- Néoplasies impliquées : lors de chimio d'induction ou radiothérapie ou corticothérapie

- Lymphome non-hodgkinien : de Burkitt; haut grade ; LAL; LAM, myelomes multiples
- plus rarement : LNH de bas grade, LLC ;
- très rarement : tumeurs solides chimio-sensibles.

C- Modalités thérapeutiques :

- **prophylactiques** : hydratation préalable, avc sce des apports et des sorties
alcalinisation des urines (ph= 7-7.5)
bilan bio / jr : LDH, iono, mg^{2+} , ca^{2+} , créat, urée, phosphate, fns
- **TRT proprement dit** :
 - Transfert vers une unité de soins intensifs, ECG régulier
 - Diurèse sodée alcaline > 2500 ml/m²/j avec Ph urinaire > 7,5.
 - **Uricozyme** : 1000 U/6 ou 8 h (IV). / (**allopurinol** : 10 mg/kg/jr en 2 po , si IR : 300mg/jr)
 - Lasilix® en cas de diurèse insuffisante.
 - Surveillance bi-quotidienne (ionogramme, uricémie, phosphatémie, kaliémie, rénale, LDH).
 - Epuration extra-rénale si : rétention hydrosodée, kaliémie, acidose, uricémie ou phosphorémie non contrôlées (> 2,5 mmol/l).

II. Urgences métaboliques:

3/ Sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique (SIADH):

Cancer pulmonaire à petite cellule, tumeur cérébrale , thymome

- clinique: Intoxication à l'eau (anorexie, nausée, VMS, dégoût à l'eau), asthénie, confusion. céphalée
- Biologie: Hypo Na^+ < 130 mmol / l. Avec hypo-osmolalité plasmatique, natriurèse et osmolalité urinaire élevées .
- TRT: *Restriction hydrique ++.inf 500 cc/24h
 - *Antagoniste de l'AVP (déméclocycline).
 - *Furosémide en cas d'urgence.

I. Urgences métaboliques:

4/ Insuffisance Surrénalienne:

- Symptômes: peu spécifiques: Asthénie, anorexie, nausées, VMS, douleurs abdominales, Hypotension orthostatique
- biologie: Hyponatrémie, hyperkaliémie, Hypoglycémie
- Dgc de certitude: ACTH et cortisol plasmatique (parfois test de stimulation)
- Causes :
 - Envahissement méta massif des surrénales (poumon, sein, côlon, rein, lymphome)
 - Arrêt trop rapide d'une corticothérapie (+++)
- TRT : urgent: corticothérapie substitutive